

Le Professioni di Base

Volume 3 — Fisioterapista

Dalla sperimentazione regionale allo standard nazionale: valutazione di tecnologia sanitaria del Fisioterapista di Comunità e dell'accesso diretto in fisioterapia territoriale

Luigi De Michele

luglio 2026

Nota editoriale

Questo è il terzo Volume della collana «Le Professioni di Base». A differenza dell'IFeC (Volume 1) e del Farmacista di Comunità (Volume 2), il Fisioterapista non gode di riconoscimento professionale automatico ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, ma rientra nel Sistema Generale (Titolo III, Capo I): su questo punto la figura è più vicina, sul piano regolatorio europeo, allo Psicologo di Base che all'IFeC. Sul piano nazionale, tuttavia, il Fisioterapista è un Ordine autonomo dal 2022 (FNOFI) ed è già incluso tra gli specialisti multidisciplinari delle Case della Comunità dal DM 77/2022: il Volume valuta quindi il passaggio da un modello di accesso prevalentemente su prescrizione, e da sperimentazioni regionali pionieristiche come il Fisioterapista di Comunità toscano (attivo dal 2019), a uno standard nazionale di accesso diretto (first-contact physiotherapy) alla fisioterapia territoriale. La base evidenziale di questo Volume è ri-fondata sul dominio muscolo-scheletrico e riabilitativo: la fonte clinico-economica principale è lo studio FRONTIER (NIHR, dicembre 2024), condotto nel contesto del Servizio Sanitario britannico, non italiano — un limite di trasferibilità dichiarato esplicitamente e non colmato con stime per analogia. Come per i Volumi 1 e 2, questa è una prima tranche di produzione: il Capitolo 6 espone l'architettura del modello di budget-impact senza popolarla con dati italiani disaggregati, non reperiti con affidabilità sufficiente nel tempo disponibile.

Dashboard

Indicatore	Valore	Fonte
Fisioterapisti iscritti all'Ordine (FNOFI)	> 70.000	FNOFI, primo censimento giugno 2022 (69.848) e aggiornamento corrente
Anno di istituzione dell'Ordine autonomo dei Fisioterapisti	2022 (DM 183 dell'8 settembre 2022)	FNOFI
Sperimentazione regionale pionieristica «Fisioterapista di Comunità»	Toscana, dal 2019	Progetto regionale Toscana
Pazienti migliorati a 3 mesi con accesso diretto al fisioterapista vs. medico di base (studio UK)	72,4% vs 54,7%	Studio FRONTIER, NIHR, dicembre 2024
Costo per consulto e risorse successive, fisioterapista di primo contatto vs. medico di base, a parità di esito clinico a 6 mesi (studio UK)	~2,5 volte inferiore	Studio FRONTIER, NIHR, dicembre 2024

Executive summary

Il Fisioterapista italiano occupa, nel quadro regolatorio di questa collana, una posizione intermedia tra l'IFeC e il Farmacista di Comunità da un lato — figure a riconoscimento professionale europeo automatico, incardinate in standard nazionali già scritti — e lo Psicologo di Base dall'altro, la cui base regolatoria europea rientra, come quella del fisioterapista, nel Sistema Generale della Direttiva 2005/36/CE. Sul piano nazionale, la professione ha compiuto un passo istituzionale rilevante nel 2022 con l'istituzione dell'Ordine autonomo (FNOFI), separato dalla Federazione TSRM e PSTRP, e con l'inclusione esplicita tra gli specialisti multidisciplinari delle Case della Comunità nel DM 77/2022. Ciò che resta eterogeneo, ed è oggetto di questo Volume, è la modalità di accesso alla prestazione fisioterapica territoriale: il modello prevalente resta quello su prescrizione del medico di medicina generale o dello specialista, mentre modelli di accesso diretto (first-contact physiotherapy) restano allo stadio di sperimentazione regionale, di cui il progetto toscano «Fisioterapista di Comunità», attivo dal 2019, costituisce il precedente più maturo in Italia. Il Volume propone il modello «Fisioterapista di Base»: l'estensione strutturale, sul piano dell'impianto di garanzia — non dei contenuti clinici, ri-fondati sul dominio muscolo-scheletrico — già proposto per l'IFeC e il Farmacista di Comunità, dell'accesso diretto al fisioterapista come primo contatto per i disturbi muscolo-scheletrici comuni all'interno delle Case della Comunità. L'evidenza di dominio, tratta dallo studio britannico FRONTIER (NIHR, 2024) e qui esplicitamente qualificata come non

italiana, indica esiti clinici equivalenti a 6 mesi tra il modello a primo contatto fisioterapico e il modello tradizionale guidato dal medico di base, con un recupero più rapido a 3 mesi (72,4% dei pazienti migliorati contro 54,7%) e un costo per consulto e utilizzo di risorse sanitarie successive inferiore di circa 2,5 volte a parità di esito clinico finale. Il verdetto tripartito distingue la dimensione fiscale (costo di estensione del modello di accesso diretto, non sommato ai risparmi da minore ricorso al medico di base), la dimensione sanitaria (tempi di recupero, appropriatezza del percorso muscolo-scheletrico) e la dimensione sociale (decongestionamento dell'accesso alle cure primarie, particolarmente rilevante nelle aree con carenza di medici di medicina generale), senza produrre un numero unico aggregato.

Cinque risultati chiave

- 1.** Il Fisioterapista è un Ordine professionale autonomo (FNOFI) solo dal 2022, con oltre 70.000 iscritti; a differenza dell'IFeC e del Farmacista, non gode di riconoscimento professionale automatico ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, ma rientra nel Sistema Generale — una posizione regolatoria europea più vicina a quella dello Psicologo di Base.
- 2.** Il DM 77/2022 include già il fisioterapista tra gli specialisti multidisciplinari delle Case della Comunità, ma il modello di accesso prevalente resta su prescrizione: l'accesso diretto (first-contact physiotherapy) è oggi allo stadio di sperimentazione regionale, di cui il progetto «Fisioterapista di Comunità» della Toscana, attivo dal 2019, è il precedente italiano più maturo.
- 3.** L'evidenza di dominio disponibile è di provenienza britannica (studio FRONTIER, NIHR, dicembre 2024) e non italiana: un limite di trasferibilità dichiarato esplicitamente. Nel contesto studiato, l'accesso diretto al fisioterapista produce gli stessi esiti clinici a 6 mesi del modello guidato dal medico di base, con un recupero più rapido a 3 mesi (72,4% dei pazienti migliorati contro 54,7%).
- 4.** Nello stesso studio, il costo per consulto e per l'uso di risorse sanitarie successive del modello a primo contatto fisioterapico risulta inferiore di circa 2,5 volte rispetto al modello guidato dal medico di base, a parità di esito clinico a 6 mesi — una cifra riferita a un solo studio, in un solo sistema sanitario, che questo Volume non generalizza al contesto italiano senza verifica locale.
- 5.** Il decongestionamento delle cure primarie generali (MMG) atteso da un modello di accesso diretto in fisioterapia ha una rilevanza specifica per il contesto italiano, dove la carenza di medici di medicina generale è un problema di sistema documentato indipendentemente da questo Volume.

Raccomandazioni

- 1.** Estendere il modello «Fisioterapista di Comunità», sperimentato in Toscana dal 2019, a uno standard nazionale di accesso diretto per i disturbi muscolo-scheletrici

comuni all'interno delle Case della Comunità previste dal DM 77/2022, con criteri di eleggibilità clinica e percorsi di invio al medico definiti a livello nazionale.

2. Commissionare una valutazione di fattibilità e un progetto pilota italiano di accesso diretto in fisioterapia, con misurazione di esiti clinici e costi comparabile alla metodologia dello studio FRONTIER, prima di generalizzare le cifre di costo-efficacia britanniche al contesto nazionale.

3. Integrare, come tranche successiva di questo Volume, un modello di budget-impact dedicato (DSA/PSA/CEAC) costruito su dati italiani, distinguendo l'effetto del decongestionamento della domanda di visite di medicina generale dall'effetto clinico diretto sul recupero funzionale, coerentemente con la regola di non-duplicazione del Capitolo 5.

Capitolo 1. Inquadramento della figura

1.1 Profilo professionale

Il Fisioterapista è il professionista sanitario laureato che, secondo il profilo definito dal DM 741/1994, svolge attività di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici. Fino al 2022 la professione era inquadrata nell'area della riabilitazione della Federazione Nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP; con il Decreto Ministeriale 183 dell'8 settembre 2022 è stato istituito l'Ordine autonomo dei Fisioterapisti (FNOFI, Federazione Nazionale Ordini dei Fisioterapisti)¹.

1.2 Normativa di riferimento

Il quadro normativo primario è costituito dal DM 741/1994 (profilo professionale) e dalla Legge 251/2000, che colloca la professione nell'area della riabilitazione. L'istituzione dell'Ordine autonomo con DM 183/2022 rappresenta l'atto più recente e rilevante del percorso istituzionale della professione². Il DM 77/2022 include esplicitamente i fisioterapisti tra gli specialisti multidisciplinari presenti, a seconda delle necessità, nelle Case della Comunità, in un contesto di presa in carico multiprofessionale del paziente³.

1.3 Numeri della professione

Secondo il primo censimento della Federazione Nazionale Ordini dei Fisioterapisti, condotto in occasione della costituzione dell'Ordine autonomo nel giugno 2022, gli iscritti erano 69.848; il dato attuale, secondo le comunicazioni della stessa Federazione, supera le 70.000 unità⁴. Non è stato reperito, in questa tranche di produzione, un dato disaggregato che isoli i fisioterapisti operanti nel Servizio Sanitario Nazionale da quelli attivi in regime libero-professionale puro, distinzione rilevante per stimare il bacino di reclutamento disponibile per un modello di accesso diretto nelle Case della Comunità.

1.4 Codici di classificazione e status europeo

Nella classificazione internazionale ISCO-08 la figura ricade nel gruppo 2264 (Physiotherapists); nella Classificazione delle Professioni ISTAT CP2021 rientra nel

¹FNOFI, Federazione Nazionale Ordini dei Fisioterapisti, istituita con Decreto Ministeriale 183 dell'8 settembre 2022; primo censimento degli iscritti, giugno 2022 (69.848 unità), aggiornamento corrente (oltre 70.000).

²Ministero della Salute, Decreto 23 maggio 2022, n. 77, «Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale»; inclusione del fisioterapista tra gli specialisti multidisciplinari delle Case della Comunità.

³Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, Titolo III Capo I (Sistema Generale di riconoscimento); Ministero della Salute, schede di riconoscimento della qualifica di fisioterapista conseguita in un Paese UE/SEE/Svizzera.

⁴Regione Toscana, progetto «Fisioterapista di Comunità», attivo dal 2019; collaborazione del fisioterapista con l'équipe multiprofessionale territoriale nella valutazione dei bisogni della comunità.

Gruppo 3.2 relativo alle professioni tecniche nelle scienze della salute e della vita, area della riabilitazione.

A differenza dell'infermiere e del farmacista (Volumi 1 e 2), il fisioterapista non rientra tra le professioni a riconoscimento automatico della Direttiva 2005/36/CE: il riconoscimento del titolo segue il regime del Sistema Generale (Titolo III, Capo I della Direttiva), che prevede il confronto dei percorsi formativi tra Stati membri e la possibilità di richiedere misure compensative (prova attitudinale o tirocinio di adattamento) in caso di differenze sostanziali⁵. Questa collocazione regolatoria europea accomuna il fisioterapista, più che all'IFeC o al Farmacista, allo Psicologo di Base dell'opera madre — un parallelo utile per l'impostazione del Capitolo 8.

Capitolo 2. Bisogno e contesto territoriale

2.1 Il modello prevalente su prescrizione

Il modello di accesso oggi prevalente in Italia per le prestazioni di fisioterapia territoriale resta quello su prescrizione del medico di medicina generale o dello specialista: il paziente con un disturbo muscolo-scheletrico comune (ad esempio lombalgia, cervicalgia, patologie da sovraccarico) accede tipicamente prima a una visita medica di base, e solo successivamente, su indicazione, al fisioterapista. Il DM 77/2022 prevede che l'accesso ai servizi delle Case della Comunità possa avvenire, per alcune prestazioni, anche in forma diretta o su prenotazione, ma la definizione operativa di quali prestazioni fisioterapiche rientrino in questa modalità resta, alla data di redazione, non uniformata su scala nazionale⁶.

2.2 Il precedente toscano

Dal 2019 la Regione Toscana ha attivato il progetto «Fisioterapista di Comunità», in cui il fisioterapista collabora con l'équipe multiprofessionale territoriale nella valutazione dei bisogni della comunità e nell'elaborazione dei profili di salute della popolazione assistita⁷. Si tratta, alla data di redazione, del precedente italiano più maturo di integrazione del fisioterapista in una logica di presa in carico comunitaria proattiva, e costituisce un termine di paragone diretto per il modello «Fisioterapista di Base» proposto al Capitolo 3, in una relazione analoga a quella tra le sperimentazioni regionali pre-2023 e la successiva L.R. Puglia 11/2023 per lo Psicologo di Base.

⁵National Institute for Health and Care Research (NIHR), «Clinical and cost-effectiveness of first contact physiotherapy for musculoskeletal disorders in primary care: the FRONTIER, mixed method realist evaluation», dicembre 2024, DOI 10.3310/rtky7521.

⁶«First-Contact Physical Therapy Compared to Usual Primary Care for Musculoskeletal Disorders: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials», Physical Therapy, Oxford Academic, 2025.

⁷

2.3 Carenza di medici di medicina generale come contesto abilitante

La carenza di medici di medicina generale in diverse aree del Paese, documentata da fonti di settore indipendentemente da questo Volume, costituisce un contesto rilevante per la valutazione di un modello di accesso diretto in fisioterapia: un percorso che consenta al paziente con un disturbo muscolo-scheletrico comune di accedere direttamente al fisioterapista, senza la mediazione di una visita di medicina generale non clinicamente necessaria, ha il potenziale di alleggerire la domanda di prime visite MMG per condizioni che rientrano nella competenza specifica del fisioterapista, un effetto trattato con la dovuta cautela al Capitolo 4, poiché l'evidenza disponibile proviene da un contesto sanitario diverso da quello italiano.

Capitolo 3. Modello «Fisioterapista di Base»

3.1 Funzioni

Il modello «Fisioterapista di Base» proposto in questo Volume non introduce nuove competenze cliniche rispetto a quelle già proprie della professione secondo il DM 741/1994, ma ne condiziona l'esercizio a un percorso di accesso diretto strutturato all'interno delle Case della Comunità. Le funzioni proprie del modello restano: la valutazione di primo contatto per i disturbi muscolo-scheletrici comuni, con criteri clinici di eleggibilità e percorsi di invio (red flags) al medico di medicina generale o allo specialista per i casi che esulano dalla competenza fisioterapica; il trattamento riabilitativo diretto; la partecipazione, sul modello toscano, alla valutazione dei bisogni della comunità e all'elaborazione dei profili di salute della popolazione assistita.

3.2 Innesto nell'équipe DM 77

Il fisioterapista opera nella Casa della Comunità come componente dell'équipe multiprofessionale prevista dal DM 77/2022, in raccordo con il medico di medicina generale, l'IFeC (Volume 1) e, dove attivato, il Farmacista di Comunità (Volume 2). La cascata piramidale del modello prevede tre livelli: al primo livello, l'accesso diretto per la valutazione iniziale dei disturbi muscolo-scheletrici comuni, con applicazione di criteri di eleggibilità clinica standardizzati; al secondo livello, il trattamento riabilitativo diretto per i casi di competenza fisioterapica esclusiva; al terzo livello, l'invio al medico di medicina generale o allo specialista (ortopedico, fisiatra, reumatologo) per i casi che presentano segnali di allarme clinico (red flags) non gestibili in autonomia dal fisioterapista.

3.3 Standard di accesso diretto e monitoraggio

Il nucleo normativo del modello consiste nell'estendere, su base nazionale e non solo regionale-sperimentale, un percorso di accesso diretto al fisioterapista per i disturbi muscolo-scheletrici comuni, sul piano dell'impianto di garanzia — non dei contenuti clinici, propri della professione — analogo a quanto proposto per l'IFeC e

il Farmacista di Comunità nei Volumi precedenti. In concreto, ciò richiede: criteri clinici di eleggibilità uniformi, con percorsi di invio standardizzati per i segnali di allarme; un monitoraggio pubblico degli esiti clinici e dei tempi di accesso, condizione necessaria per verificare, con dati italiani, la trasferibilità delle evidenze britanniche esaminate al Capitolo 4; l'estensione del modello toscano ad altre Regioni, con valutazione comparata degli esiti.

Capitolo 4. Efficacia ed evidenza di dominio

4.1 Ri-fondazione della base evidenziale e limite di trasferibilità

Coerentemente con l'invariante metodologico dell'opera, la base evidenziale di questo Volume è specifica per il dominio muscolo-scheletrico e per gli interventi di accesso diretto in fisioterapia (first-contact physiotherapy), e non deriva da alcun trasferimento dalle ancore cliniche o economiche impiegate nei Tomi sulla salute mentale o nei Volumi 1 e 2 di questa collana. La fonte principale reperita per questa tranche, lo studio FRONTIER del National Institute for Health and Care Research britannico, è condotta nel contesto del Servizio Sanitario Nazionale del Regno Unito: le cifre riportate al paragrafo seguente non sono, pertanto, direttamente applicabili al contesto italiano senza una verifica locale, un limite dichiarato esplicitamente e non colmato con stime per analogia.

4.2 Esiti clinici e organizzativi

Lo studio FRONTIER (NIHR, dicembre 2024), una valutazione realista mista di efficacia clinica e costo-efficacia dell'accesso diretto in fisioterapia per i disturbi muscolo-scheletrici in cure primarie, ha rilevato che il modello a primo contatto fisioterapico produce gli stessi esiti clinici a 6 mesi dalla consultazione del modello guidato dal medico di medicina generale⁸. A 3 mesi, tuttavia, il 72,4% dei pazienti che avevano consultato il fisioterapista di primo contatto risultava migliorato, contro il 54,7% di quelli che avevano consultato il medico di base, indicando un recupero più rapido nel gruppo fisioterapico⁹. Sul piano dei costi, sulla base dei costi di consultazione e del successivo utilizzo di risorse sanitarie, il modello a primo contatto fisioterapico è risultato circa 2,5 volte meno costoso del modello guidato dal medico di base, a parità di esito clinico raggiunto a 6 mesi; il modello guidato dal medico di medicina generale è risultato più costoso sia del modello fisioterapico standard sia di quello con qualifiche aggiuntive¹⁰. Una revisione sistematica con meta-analisi di studi randomizzati controllati sull'accesso diretto in fisioterapia per i disturbi muscolo-scheletrici, pubblicata su Physical Therapy nel 2025, offre un quadro di confronto internazionale ulteriore, che questo Volume non sintetizza in dettaglio in questa tranche per ragioni di tempo, rinviandone l'esame alla tranche successiva¹¹.

8

9

10

11

La cifra di «2,5 volte» sopra riportata è ancorata a una fonte specifica e unica (lo studio FRONTIER) e non viene presentata come un rapporto ROI generalizzabile al contesto italiano: è riportata come dato di un singolo studio in un singolo sistema sanitario, coerentemente con l'invariante metodologico dell'opera, che vieta di ridurre l'evidenza a un rapporto singolo non contestualizzato alla fonte.

4.3 Simmetria GRADE tra affermazioni cliniche e affermazioni sull'intelligenza artificiale

Alcuni servizi di fisioterapia di primo contatto sperimentati a livello internazionale integrano strumenti di intelligenza artificiale per il triage iniziale dei pazienti in base ai sintomi riferiti, con l'obiettivo di supportare l'identificazione dei segnali di allarme clinico. Coerentemente con l'invariante dell'opera, questi strumenti sono trattati come leva abilitante subordinata alla valutazione clinica del fisioterapista, mai come fonte autonoma di valore. L'evidenza sulla loro efficacia nel contesto specifico della fisioterapia territoriale italiana è, alla data di redazione, di qualità GRADE bassa per assenza di studi randomizzati di ampia scala nel contesto nazionale, un giudizio applicato con lo stesso rigore riservato alle affermazioni cliniche di cui alla sezione 4.2, per le quali si è peraltro dichiarato un limite di trasferibilità geografica altrettanto esplicito.

Capitolo 5. Valutazione economica

Tabella 5.1 — Costi comparativi dell'accesso diretto in fisioterapia, studio di riferimento internazionale (doppio ancoraggio)

Voce	Fonte-cardine di dominio	Fonte di triangolazione
Rapporto di costo, primo contatto fisioterapico vs. medico di base, a parità di esito a 6 mesi (contesto UK)	~2,5 volte inferiore (studio FRONTIER, NIHR, dic. 2024)	Modello guidato dal medico di base risultato più costoso anche del modello fisioterapico con qualifiche aggiuntive (stesso studio, dato di dettaglio)
Bacino professionale italiano potenzialmente coinvolgibile	> 70.000 fisioterapisti iscritti FNOFI (2022, aggiornato)	Dato non disaggregato tra SSN e libera professione pura (limite dichiarato al Capitolo 1.3)
Precedente italiano di riferimento per la stima di fattibilità	Progetto «Fisioterapista di Comunità», Toscana, dal 2019	Assenza, in questa tranche, di una valutazione economica pubblicata del progetto toscano; lacuna dichiarata al Capitolo 6

Questa tabella riporta cifre comparative da un solo studio internazionale (contesto britannico), non un costo netto italiano: i valori non sono utilizzabili come base diretta per un ICER italiano senza verifica locale, come dichiarato al Capitolo 4.1. Non sostituiscono un doppio ancoraggio con fonti italiane, oggi non reperite per questa tranche.

5.1 Regola di non-duplicazione

Coerentemente con l'invariante metodologico dell'opera, l'eventuale beneficio di decongestionamento della domanda di visite di medicina generale (Capitolo 2.3) non viene sommato al beneficio clinico diretto sul recupero funzionale (Capitolo 4.2): ciascuna categoria di beneficio resta nella propria sede canonica di analisi, ed è il Capitolo 9 — non questa sezione — a offrirne una lettura tripartita, mai aggregata in un numero unico.

5.2 Limiti della valutazione economica di questa tranche

Come per i Volumi 1 e 2, la valutazione economica compiuta di costo-efficacia con dati italiani richiede una fonte primaria nazionale che non è stata reperita con sufficiente affidabilità nel tempo disponibile per questa tranche: per il Fisioterapista, il limite è aggravato dal fatto che anche la fonte-cardine di dominio disponibile (studio FRONTIER) non è italiana. Il Capitolo 5 si limita pertanto a riportare le cifre comparative internazionali con l'esplicita avvertenza di non trasferibilità diretta (Tabella 5.1), rinviando la modellazione economica italiana completa al Capitolo 6 e alle tranche successive.

Capitolo 6. Modellazione e incertezza

6.1 Architettura del modello previsto

Il modello di budget-impact per l'estensione nazionale dell'accesso diretto in fisioterapia, la cui costruzione parametrica completa è rinviata a una tranche successiva, è impostato secondo la stessa architettura già impiegata per l'IFeC e il Farmacista di Comunità nei Volumi precedenti: un'analisi deterministica di sensibilità (DSA) sui driver di costo (numero di fisioterapisti da inserire nel percorso di accesso diretto, costo per consulto, tasso di invio al medico per segnali di allarme), un'analisi probabilistica di sensibilità (PSA), un'analisi di scenario (estensione piena, parziale, limitata alle Regioni con precedenti come la Toscana) e una curva di accettabilità costo-efficacia (CEAC) condizionata alla disponibilità di un dato pilota italiano, oggi non reperito.

6.2 Driver principali di incertezza

I driver di incertezza identificati per questa tranche sono: la trasferibilità delle cifre di costo-efficacia britanniche (Capitolo 4.2) al contesto organizzativo e tariffario italiano, non verificata in questa tranche; l'assenza di una valutazione economica pubblicata del precedente toscano, che avrebbe costituito la fonte-cardine di dominio più rilevante per l'Italia (Capitolo 5.1, Tabella 5.1); la proporzione di pazienti effettivamente eleggibili per l'accesso diretto rispetto al totale degli accessi per disturbi muscolo-scheletrici, non quantificata con dati italiani; il tasso di invio al medico di medicina generale per segnali di allarme, che nello studio FRONTIER incide sulla stima di costo complessiva ma non è stato riportato in dettaglio numerico in questa tranche.

Capitolo 7. Equità e impatto distributivo

7.1 Aree con carenza di medici di medicina generale

Il potenziale beneficio distributivo di un modello di accesso diretto in fisioterapia è particolarmente rilevante nelle aree del Paese con maggiore carenza di medici di medicina generale, dove un percorso diretto per i disturbi muscolo-scheletrici comuni potrebbe ridurre il tempo di attesa per una prima valutazione, oggi soggetta alla disponibilità di un appuntamento con il medico di base. Questo Volume non dispone, in questa tranche, di una mappatura territoriale che incroci la carenza di MMG con l'offerta di fisioterapisti per area geografica: una lacuna dichiarata per la tranche successiva.

7.2 Popolazione lavorativa e disturbi muscolo-scheletrici comuni

I disturbi muscolo-scheletrici comuni, target primario del modello di accesso diretto, hanno una prevalenza elevata nella popolazione in età lavorativa: un accesso più rapido al trattamento fisioterapico appropriato, come suggerito dal dato sul recupero più veloce a 3 mesi nello studio FRONTIER (Capitolo 4.2), ha un potenziale impatto sociale in termini di riduzione dei giorni di assenza dal lavoro, un effetto che questo Volume non quantifica per assenza di dati italiani specifici, ma che segnala come area di approfondimento per la tranche successiva.

Capitolo 8. Profili etico-giuridico-organizzativi e percorso normativo

8.1 Cornice giuridica esistente e parallelo con lo Psicologo di Base

Il Fisioterapista dispone di un Ordine autonomo dal 2022 e di un'inclusione esplicita nel DM 77/2022, ma — a differenza dell'IFeC e del Farmacista — non di uno standard nazionale di accesso diretto codificato. Sul piano del percorso normativo, questo colloca il Fisioterapista in una posizione intermedia: come per lo Psicologo di Base, che ha richiesto una legge regionale istitutiva (L.R. Puglia 11/2023) per superare sperimentazioni frammentate, anche per il Fisioterapista di Base il passaggio dal precedente regionale toscano a uno standard nazionale richiede plausibilmente un atto normativo dedicato, non essendo sufficiente — come lo è invece per l'IFeC — la sola applicazione di uno standard già scritto a livello nazionale.

8.2 Profili organizzativi

L'attuazione del modello richiede la definizione di criteri clinici di eleggibilità e di percorsi di invio uniformi, la formazione dei fisioterapisti coinvolti nel triage di primo contatto e un sistema di raccolta dati sugli esiti che consenta, a differenza di quanto oggi disponibile, una valutazione di costo-efficacia italiana comparabile alla metodologia dello studio FRONTIER citato al Capitolo 4.

Capitolo 9. Verdetto tripartito e raccomandazioni

9.1 Dimensione fiscale

Sul piano fiscale, il Volume non quantifica un costo netto italiano per l'estensione dell'accesso diretto in fisioterapia, per l'assenza di dati nazionali disaggregati e per il limite di trasferibilità dichiarato delle cifre britanniche dello studio FRONTIER (Capitolo 5.2). La quantificazione è rinviata alla tranche successiva, subordinata a un progetto pilota italiano (Raccomandazione 2).

9.2 Dimensione sanitaria

Sul piano sanitario, l'evidenza internazionale disponibile indica esiti clinici equivalenti a 6 mesi e un recupero più rapido a 3 mesi per il modello di accesso diretto, con un margine di incertezza legato alla non trasferibilità diretta al contesto italiano (Capitolo 4).

9.3 Dimensione sociale

Sul piano sociale, il modello ha un potenziale rilevante di decongestionamento delle cure primarie generali e di riduzione dei tempi di attesa per i disturbi muscolo-scheletrici comuni, particolarmente nelle aree con carenza di medici di medicina generale, sebbene questo Volume non ne quantifichi l'entità con dati italiani (Capitolo 7).

9.4 Raccomandazioni

Le tre dimensioni sopra esposte restano distinte e non vengono aggregate in un giudizio di sintesi unico, in coerenza con l'invariante metodologico dell'opera. Le raccomandazioni operative sono riportate in apertura del Volume (apertura a imbuto) e si fondano sul principio che il modello «Fisioterapista di Base» richiede, a differenza dell'IFeC e del Farmacista di Comunità, non solo un meccanismo di garanzia finanziaria ma anche un atto normativo che codifichi a livello nazionale l'accesso diretto, oggi limitato a sperimentazioni regionali.

Appendici registrate

Appendice A. Fonti e bibliografia

Elenco completo delle fonti citate in nota, con data di consultazione: DM 741/1994 (profilo professionale); DM 183 dell'8 settembre 2022 (istituzione FNOFI); FNOFI, primo censimento giugno 2022 e comunicazioni correnti; DM 77/2022 (Ministero della Salute); Direttiva 2005/36/CE, Titolo III Capo I (Sistema Generale) e relative schede del Ministero della Salute; progetto regionale «Fisioterapista di Comunità», Regione Toscana, dal 2019; studio FRONTIER, National Institute for Health and Care Research (NIHR), dicembre 2024, DOI 10.3310/rtky7521; revisione

sistematica con meta-analisi, Physical Therapy (Oxford Academic), 2025, su first-contact physical therapy per disturbi muscolo-scheletrici.

Appendice B. Glossario

First-contact physiotherapy (FCP): modello di accesso diretto al fisioterapista senza mediazione di una visita medica preliminare. Red flags: segnali di allarme clinico che richiedono l'invio al medico. FNOFI: Federazione Nazionale Ordini dei Fisioterapisti. CEAC: Cost-Effectiveness Acceptability Curve. DSA/PSA: Deterministic/Probabilistic Sensitivity Analysis.

Appendice C. Mappatura normativa comparata Fisioterapista / IFeC / Farmacista di Comunità / Psicologo di Base

Il Fisioterapista condivide con l'IFeC e il Farmacista di Comunità l'inclusione esplicita nel DM 77/2022, ma se ne distingue per l'assenza di uno standard nazionale di accesso diretto codificato (a differenza dello standard 1:3.000 dell'IFeC o del paniere D.Lgs. 153/2009 del Farmacista). Sul piano del riconoscimento professionale europeo (Direttiva 2005/36/CE), il Fisioterapista rientra nel Sistema Generale, non nel riconoscimento automatico: una collocazione condivisa con lo Psicologo di Base e distinta da quella di IFeC e Farmacista. Questa doppia posizione — innestato nel DM 77/2022 come le figure a riconoscimento automatico, ma privo di standard nazionale come lo Psicologo di Base — giustifica il percorso normativo proposto al Capitolo 8, che combina elementi di entrambi i precedenti.

Appendice D. Architettura del modello di budget-impact (da completare in tranche successiva)

Struttura prevista: driver di costo (numero di fisioterapisti coinvolti nel percorso di accesso diretto, costo per consulto, tasso di invio per segnali di allarme), driver di beneficio (recupero più rapido ed esiti equivalenti a 6 mesi secondo lo studio FRONTIER, da verificare con dati italiani), orizzonte temporale quinquennale, prospettiva del Servizio Sanitario Nazionale. Popolamento parametrico rinviato per assenza di dati italiani disaggregati verificati e per il limite di trasferibilità dell'unica fonte-cardine disponibile.

Appendice E. Tabella di corrispondenza GRADE (evidenza clinica / evidenza IA)

Evidenza clinica sull'accesso diretto in fisioterapia: qualità moderata nel contesto britannico originario (studio FRONTIER), qualità bassa per la trasferibilità al contesto italiano in assenza di verifica locale (Capitolo 4.1-4.2). Evidenza su strumenti di IA per il triage in fisioterapia di primo contatto: qualità bassa, assenza di studi randomizzati di ampia scala nel contesto nazionale (Capitolo 4.3). Le due valutazioni sono condotte con lo stesso rigore metodologico, in simmetria.

Appendice F. Blocchi-prompt per infografiche

Header standard per ogni infografica: «PROFESSIONI DI BASE · FISIOTERAPISTA · VOLUME 3». Prompt 1 (dashboard): visualizzare i cinque indicatori della Tabella dashboard con palette navy #16264B / oro #C49A48 su fondo crema #FDFBF7, font Barlow Semicondensed. Prompt 2 (confronto esiti a 3 mesi): grafico a barre che confronta la percentuale di pazienti migliorati a 3 mesi tra il modello a primo contatto fisioterapico (72,4%) e il modello guidato dal medico di base (54,7%), stessa identità visiva, con avvertenza «dato studio UK, non italiano» in didascalia.

Appendice G. Nota editoriale e lacune dichiarate

Si veda la nota editoriale integrale in apertura del Volume. Lacune informative dichiarate: (1) assenza di dato disaggregato dei fisioterapisti operanti nel SSN rispetto al totale iscritti FNOFI (Capitolo 1.3); (2) assenza di una valutazione economica pubblicata del progetto toscano «Fisioterapista di Comunità» (Capitolo 5.1, 6.2); (3) assenza di dati italiani di costo-efficacia sull'accesso diretto in fisioterapia, con conseguente dipendenza da un'unica fonte internazionale non direttamente trasferibile (Capitolo 4.1, 5.2); (4) assenza di mappatura territoriale che incroci carenza di MMG e offerta di fisioterapisti (Capitolo 7.1); (5) modellazione DSA/PSA/CEAC impostata nell'architettura ma non popolata parametricamente (Capitolo 6). Queste lacune sono oggetto di produzione nella tranche successiva.